

Terapia de Esquemas

Marco teorico — Jeffrey Young

DEFINICION Y ORIGEN

Desarrollada por Jeffrey Young en los años 90 como extension de la TCC, la Terapia de Esquemas integra elementos cognitivo-conductuales, teoria del apego, Gestalt y psicoanalitico para abordar trastornos cronicos y de personalidad.

CONCEPTOS CENTRALES

Esquemas Maladaptativos Tempranos (EMT)

Patrones cognitivo-emocionales profundos y duraderos que se desarrollan en la infancia cuando las necesidades emocionales basicas no son satisfechas. Son el nucleo del trabajo terapeutico.

Necesidades Emocionales Basicas

Cinco necesidades universales cuya frustracion genera esquemas: vinculo seguro, autonomia, libertad de expresion, espontaneidad y limites realistas.

Estilos de Afrontamiento

Modos en que la persona responde al esquema: rendicion (actua desde el esquema), evitacion (huye del malestar) o sobrecompensacion (actua en contra del esquema).

Modos Esquematicos

Estados emocionales y conductuales que se activan segun el contexto. Incluyen modos de niño, modos desadaptativos de afrontamiento y el modo adulto sano.

FASES DEL TRATAMIENTO

1. Evaluacion y psicoeducacion

Identificar esquemas activados, historia de aprendizaje, vincular pasado con presente.

2. Vinculo terapeutico

Reparentalidad limitada: el terapeuta cubre parcialmente necesidades no satisfechas.

3. Cambio de esquemas

Tecnicas cognitivas, vivenciales (imagenes, silla vacia) y conductuales.

4. Consolidacion

Generalizar cambios al contexto real, fortalecer el modo adulto sano.

Clave clinica: La TE es especialmente eficaz en trastornos de personalidad, depresion cronica, ansiedad generalizada y patrones relacionales repetitivos. Requiere formacion especifica.